Station 1

Din nästa patient på medicinakuten kommer på grund av orkeslöshet och trötthet. Från triagen har du fått vitalparametrar:

- Temperatur 37,2 °C
- Andningsfrekvens 16 /minut
- Blodtryck 165/95 mmHg, puls 40 /minut

Ett EKG är taget och finns inne på rummet.

Du ska:

- **Ta adekvat anamnes**
- **Efterfråga resultat av statusundersökningar** (du behöver INTE utföra status)
- **Tolka EKG. Kommunicera din bedömning och planering för fortsatta åtgärder med patienten**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 2

Du är läkare på hälsocentral i Umeå och träffar i slutet av maj en 25-årig patient. Patienten har en känd björkpollenallergi som tidigare varit stabil på behandling med antihistamin (Desloratadin 5 mg x 1).

Patienten söker nu på grund av tilltagande besvär från ögon och näsa och önskar en mer effektiv behandling.

Din uppgift är att:

1. **Ta en adekvat anamnes för att kartlägga symtom och faktorer som kan påverka.**
2. **Förklara, och motivera, om ytterligare utredning behövs eller ej.**
3. **Informera om lämplig kompletterande behandling.**

(Du skall inte utföra status.)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3

Du är läkare på akutmottagningen och blir tillfrågad om att titta på en 69 årig person på triaget. Hen söker på grund av plötsligt påkommen svaghet för 1 timme sedan och har nu fått hjälp av sin partner till akutmottagningen. Patienten är sen tidigare väsentlig frisk förutom mild hypertoni. Står på Enalapril, i övrigt inga läkemedel.

Du ska: Utföra anvisade delar av nervstatuset NIHSS och rapportera fynden enligt SBAR till din bakjour och föreslå nästa åtgärd.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4

VILOSTATION

Station 5

Du är läkare på medicinakuten. Där finns många patienter som inte träffat läkare ännu och du försöker få en överblick över dem. Du gör en snabb, första bedömning av en 55-årig patient som söker på grund av andfåddhet och uttalad om bägge benen och som är triagerad som orange.

Triagesköterskan har dokumenterat följande:

Luftväg:	Fri.
Syremättnad:	94% utan extra syrgas
Andningsfrekvens:	26/min
Blodtryck:	165/85 mmHg
Puls:	88/min
Vakenhetsgrad:	Vaken och alert
Kroppstemperatur:	36,8 °C

Du ska:

- **Ta en kort anamnes som är relevant i situationen**
- **Genomföra relevanta statusmoment för att kunna prioritera handläggningen**
- **Kommer fram till en plan för initial utredning av patienten under den första timmen på akutmottagningen.**
  Ditt differentialdiagnostiska resonemang och planerad initial utredning skall du kort förklara för patienten (ej för bedömaren)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 6

Du är underläkare på medicinakuten. En 22-årig patient har inkommit p.g.a. misstänkt överdos av läkemedel. Patienten är vaken och stabil.

Din uppgift är att:

1. **Ta en relevant anamnes (4 minuter)**
2. **Rapportera till bakjour (2 minuter)**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7

Patient med anemi.
På din öppenvårdsmottagning söker en 34-årig tidigare frisk kvinna för trötthet.

Uppgiften är värdera patientens symtom och fastställa sannolik orsak till anemin samt föreslå ett bekräftande laboratorieprov. Därefter ge lämplig ordination med adekvat instruktion till patienten inklusive uppföljning.

Blodstatus visar:

Parameter	Uppmätt värde	Normalvärde	Enhet
Hb	78	134–170	g/L
MCV	76	82–98	fL
MCHC	296	317–357	g/L
RDW	16	12.3–14.3	%
LPK	6.0	3.5–8.8	$x10^9$/L
TPK	250	145–348	$x10^9$/L

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 8

VILOSTATION

Station 9

85-åring har varit inlagd fem dagar för lunginflammation och fått intravenösa antibiotika. Idag utskrivning med peroralt penicillin i fem dagar. Har även fått insatt Metformin.

<u>Din uppgift</u>: genomföra utskrivning samtal med patienten

- **informera om sjukdomar**
- **informera om nyinsatta läkemedel**
- **informera om planering/uppföljning**

BAKGRUND

Nuvarande sjukdomar: Hypertoni, diabetes typ 2 (tidigare utan läkemedelsbehandling)

Socialt: ensamboende i eget hem. Hemtjänst två gånger per dag för stöd med läkemedel och mat

Allergi: Ingen känd

Läkemedel vid inkomst: Candesartan/hydroklortiazid 16/12,5 mg x 1

Tobak/alkohol: aldrig nyttjat

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10

En 55 årig man som inte haft andra kontakter med hälsocentralen än för COVID-vaccinationer söker akut på vårdcentralen på grund av övergående bröstsmärtor. Mottagningssköterskan har tagit:

Blodtryck: 170/80
Puls: 90
Saturation: 96%
Andningsfrekvens: 14
EKG: finns på rummet

Din uppgift är att:

1. **Tolka EKG**
2. **Genomföra en relevant komplettering av anamnesen avseende bröstsmärtorna**
3. **Utifrån din sammanfattande bedömning av EKG och anamnes informera patienten om misstänkt diagnos och ta ställning till adekvat åtgärd**

*(Du ska **inte** göra status på denna station)*

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11

VILOSTATION

Station 12

Du träffar en patient med astma som bara har behandlats med kortverkande beta-2-stimulerare (SABA) vid behov.

Spirometri visar bibehållen lungfunktion, men patienten har astmasymtom 3–4 gånger per vecka och Astma Control Test (ACT) 12 p

Detta motiverar att du sätter in underhållsbehandling med en fast kombination av inhalationssteroid och snabb- och långverkande beta-2-stimulerare (ICS + FABA) samt extra doser med samma inhalator vid behov.

Du ska:

1. **Välja lämplig inhalator för patientens astma**
2. **Informera patienten om inhalatorn och verkan av dom läkemedel som ingår (ICS + FABA regelbundet + vid behov)**
3. **Patienten har nu fått instruktion av astmasköterskan om inhalatorteknik. Din uppgift är nu att kontrollera om patienten har bra inhalationsteknik och vet hur medicineringen ska tas**

Du får informera/kommentera verbalt.

Du ska INTE ta anamnes eller status

OBS! Av hygienskäl ska endast figuranten/patienten hantera inhalatorerna

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13

Du jobbar som underläkare på BFM, och ska titta på 3 lungröntgenbilder. Med dig har du en läkarstudent som du ska undervisa medan du jobbar. **Bedöm bilderna på datorn och svara på studentens frågor.**

Remittenterna har gett knapphändig information i remisserna:

- Fall 1: Fått CVK på höger sida. Optimalt läge nedre 1/3 av vena cava superior/höger förmak. Tacksam rtg på IVA. Läge?
- Fall 2: Tetrapares. Nedsatt andningsljud dx. Patologi?
- Fall 3: Frisk. Hälsokontroll via företags-hälsan. Patologi?

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 14

Din nästa patient på hälsocentralen är en 35-årig kvinna som kommer på grund av viktnedgång sedan 1–2 månader. Ett status har redan tagits av kollega:

Status:

Allmäntillstånd: Ingen dyspné, inga perifera ödem

Cor: Regelbunden rytm 95/min

Blodtryck: 110/70 mmHg

Lungor: Normala andningsljud bilateralt

Lymfkörtlar: Inga palpabla förstorade lymfkörtlar

Buk: Mjuk, inga palpabla resistenser eller organförstoringar. Ömmar lite i epigastriet.

Du ska:

1. **Ta en relevant anamnes**
2. **Informera patienten möjliga orsaker och fortsatt handläggning**

Du ska INTE komplettera status

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 15

VILOSTATION

Station 16

Du är BT-läkare och träffar en 68-årig man på hälsocentralen. Han har genomgått 24-timmarsblodtrycksmätning och provtagning.

Medelblodtryck under dygnet: 145/92 mmHg.

Non-HDL: 5,5 mmol/l.

SCORE2-risk: 14%.

Patienten har inte diabetes och ingen läkemedelsbehandling.

Du ska

- **ta en adekvat anamnes utifrån den patientcentrerade konsultationsmodellen, där de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom ska vara med.**

- **informera patienten om hans SCORE2-risk och förklara vad den innebär.**

Du ska INTE undersöka patienten.

Du ska INTE ta ställning till eventuell behandling.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 17

En 56-årig man kommer till akutmottagningen på grund av hög feber 39,5°C, huvudvärk, magsmärtor och tilltagande förvirring sedan drygt ett dygn. Patienten har försämrats sista timmarna. Patienten inkommer medvetandesänkt och kan endast svara stönande på frågor. Medföljande patienten är dennes mycket oroliga sambo. Patienten bor i eget boende och arbetar som konsult.

Du ska:

- **Ta en adekvat anamnes genom att kommunicera med orolig anhörig**
- **Bedöma svårighetsgraden av sjukdomen**
- **<u>Ge förslag på och förklara din bedömning, initiala handläggning och lämplig behandling (och typ) för anhörig</u> (du behöver INTE ange exakta preparat eller doser).**

Du behöver INTE göra kroppsundersökning

Vitalparametrar finns inne på rummet

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 18

Du kommer in på en vårdsal och hittar en till synes livlös person på golvet.

Vad gör du?

(Patienten är bekräftat COVID-negativ)

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 19

VILOSTATION